

Tema 34. Drogodependencias

Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las drogas. Últimas tendencias en el consumo de drogas en nuestra sociedad.

FUENTES

Apuntes del tema 34 (apuntes propios, NO texto oficial)

Redactados para esta plataforma porque el programa pide materia que no recoge ninguna norma. Pendientes de revisión.

Alcance en este tema: Todo el tema.

Documento generado el 2026-09-03 para Atenea Policial a partir de los textos consolidados del BOE. Contiene únicamente los preceptos que el programa oficial asigna a este tema.

Drogodependencias

CONCEPTOS BÁSICOS

DROGA. La Organización Mundial de la Salud la define como toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.

De la definición se deducen tres notas: actúa sobre el sistema nervioso central, altera su funcionamiento y puede generar dependencia. El concepto es farmacológico y no coincide con el de sustancia ilegal: el alcohol y el tabaco son drogas, y muchos fármacos lo son.

CONSUMIDOR. Tipologías habituales según el patrón de consumo:

Experimental: prueba puntual por curiosidad, sin continuidad.

Ocasional: consume de forma intermitente, sin periodicidad fija y manteniendo el control.

Habitual: el consumo se incorpora a la rutina.

Compulsivo o dependiente: el consumo se convierte en el eje de la vida y aparece pérdida de control.

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN. La vía condiciona la rapidez del efecto y el riesgo asociado:

Oral o digestiva: la más lenta.

Pulmonar o inhalada (fumada): efecto muy rápido, porque el paso a la sangre se produce en el alvéolo.

Intranasal o esnifada: absorción por la mucosa nasal.

Parenteral o inyectada (intravenosa, intramuscular, subcutánea): la más rápida e intensa, y la de mayor riesgo sanitario por sobredosis y por transmisión de enfermedades al compartir material.

Otras: sublingual, rectal y transdérmica.

ADICCIÓN. Enfermedad crónica y recidivante caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivos de una sustancia pese a las consecuencias adversas, con pérdida de control sobre el consumo.

DEPENDENCIA. Necesidad de continuar consumiendo. Se distingue:

Dependencia **FÍSICA**: el organismo se ha adaptado a la sustancia y su supresión provoca el **SÍNDROME DE ABSTINENCIA**, conjunto de signos y síntomas físicos que aparecen al interrumpir el consumo.

Dependencia **PSÍQUICA O PSICOLÓGICA**: deseo intenso e irresistible de consumir (craving) por los efectos placenteros o por evitar el malestar. Es la más difícil de superar y la que explica las recaídas años después de la desintoxicación.

TOLERANCIA. Estado de adaptación por el que se necesitan dosis crecientes para obtener el mismo efecto que antes se lograba con dosis menores. La tolerancia **CRUZADA** se produce cuando la tolerancia adquirida a una sustancia se extiende a otras del mismo grupo. La tolerancia **INVERSA** o sensibilización es el fenómeno contrario: dosis menores producen efectos mayores.

POLITOXICOMANÍA. Consumo simultáneo o alternante de varias sustancias, generalmente para potenciar efectos o para contrarrestar los indeseados de otra. Es el patrón hoy predominante y multiplica el riesgo por las interacciones: la mezcla de depresores como alcohol y benzodiazepinas, o el consumo alterno de estimulantes y depresores.

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS

La clasificación más útil y la más preguntada es la que atiende a su efecto sobre el sistema nervioso central:

DEPRESORAS. Reducen la actividad del sistema nervioso central: producen sedación, relajación, somnolencia y, en dosis altas, depresión respiratoria.

Alcohol etílico. Opiáceos: opio, morfina, heroína, metadona, codeína, fentanilo. Hipnóticos y sedantes: barbitúricos y benzodiacepinas. Disolventes volátiles e inhalantes.

ESTIMULANTES. Aumentan la actividad del sistema nervioso central: euforia, aumento de la vigilia, disminución del apetito y de la sensación de fatiga.

Estimulantes mayores: cocaína y anfetaminas, incluidas metanfetamina y derivados. Estimulantes menores: nicotina, cafeína, teína y derivados de la hoja de coca.

PERTURBADORAS, ALUCINÓGENAS O PSICODISLÉPTICAS. Distorsionan la percepción de la realidad.

Alucinógenos: LSD, mescalina, psilocibina. Cannabis y derivados (marihuana, hachís, aceite), habitualmente clasificados aquí por su acción perturbadora. Drogas de síntesis con efecto mixto, como el MDMA o éxtasis. Anestésicos disociativos como la ketamina o el fenciclidina.

Otras clasificaciones: por su origen (naturales, semisintéticas y sintéticas), por su situación legal (legales e ilegales) y por su uso social (institucionalizadas o no).

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL CONSUMO

Las tendencias que describen los informes españoles y europeos de los últimos años, y que conviene manejar como orientaciones y no como cifras:

El alcohol, el tabaco y el cannabis siguen siendo las sustancias de consumo más extendido, y el alcohol muy por delante de todas.

Consumo intensivo de alcohol en periodos cortos entre jóvenes, con adelanto de la edad de inicio y equiparación creciente entre chicos y chicas.

Descenso histórico del consumo de heroína por vía inyectada y del perfil clásico de dependencia asociado a ella.

Estabilidad o crecimiento del consumo de cocaína, con España entre los países europeos de mayor prevalencia.

Aumento del policonsumo, especialmente en contextos recreativos de fin de semana.

Irrupción de las NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: catinonas sintéticas, cannabinoides sintéticos y opioides sintéticos de alta potencia. Se diseñan modificando la molécula para quedar fuera de las listas de sustancias fiscalizadas, tienen potencia y toxicidad mal conocidas y se adquieren con frecuencia por internet.

Uso indebido de medicamentos, en particular hipnosedantes sin receta, con mayor prevalencia entre mujeres.

Papel creciente de internet, la mensajería cifrada, la dark web y las criptomonedas en la distribución, que desplaza parte del menudeo del espacio físico al digital.

Aparición de la figura del CHEMSEX, consumo de determinadas sustancias asociado a prácticas sexuales, con riesgos sanitarios específicos.

Consolidación de las adicciones sin sustancia o comportamentales —juego de azar y apuestas en línea, videojuegos— que comparten mecanismos neurobiológicos con las adicciones a sustancias.

